

การพยาบาล ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวด

การประเมิน การวางแผน การให้การพยาบาล
และการประเมินผลอย่างองค์รวม



ประเมินความปวด



วางแผนการพยาบาล



จัดการความปวด



ดูแลอย่างองค์รวม



ประเมินผล



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญจน์นิชา เรืองชัยทวิสุข



บรรเทาปวด อย่างเข้าใจ
ใส่ใจ อย่างองค์รวม



การพยาบาลผู้ป่วย ที่มีอาการเจ็บปวด

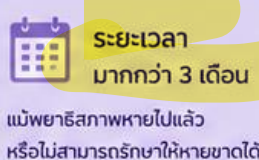
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญจน์นิชา เรืองชัยทวิสุข

1 อาการเจ็บปวดเฉียบพลัน (Acute Pain)



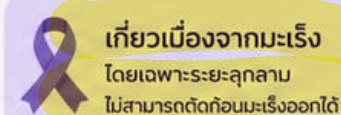
- สัญญาณเตือนว่ามีการทำลายเนื้อเยื่อ
- หลักการรักษา: ค้นหาและแก้ไขสาเหตุ ร่วมกับการบำบัดความปวดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความทุกข์ทรมาน ป้องกันภาวะแทรกซ้อน และป้องกันการเปลี่ยนเป็นความปวดเรื้อรัง

2 อาการเจ็บปวดเรื้อรัง (Chronic Non-Cancer Pain)



- ความปวดคงอยู่นานเกิน 3 เดือน
- หลักการรักษา: บำบัดปวดให้ความปวดอยู่ในระดับที่ผู้ป่วยสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี แม้ยังมีความปวดอยู่บ้าง มุ่งเน้นทำให้คุณภาพชีวิตดี ไม่ทรมานกับความปวด

3 อาการเจ็บปวดจากมะเร็ง (Cancer Pain)



- ลักษณะเหมือนความปวดเรื้อรัง และอาจมีความปวดเฉียบพลันแทรกซ้อนจากการลุกลาม หรือการรักษา เช่น การตัดเลือดในก้อนมะเร็ง ลำไส้อุดตัน การผ่าตัด เป็นต้น
- หลักการรักษา
 - 1 บำบัดความปวดเรื้อรัง โดยมุ่งให้ผู้ป่วยอยู่กับความปวดได้ โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 - 2 ถ้ามีความปวดเฉียบพลัน ให้หาสาเหตุและบำบัดความปวดเฉียบพลันอย่างมีประสิทธิภาพ
 - 3 เมื่อถึงระยะสุดท้าย บำบัดความปวดโดยคำนึงถึงความสุขสบาย (comfort care) มากกว่าคุณภาพชีวิต และอาการข้างเคียงจากยาระงับปวด



ประเมินความปวด



บำบัดความปวดอย่างเหมาะสม



ดูแลแบบองค์รวม



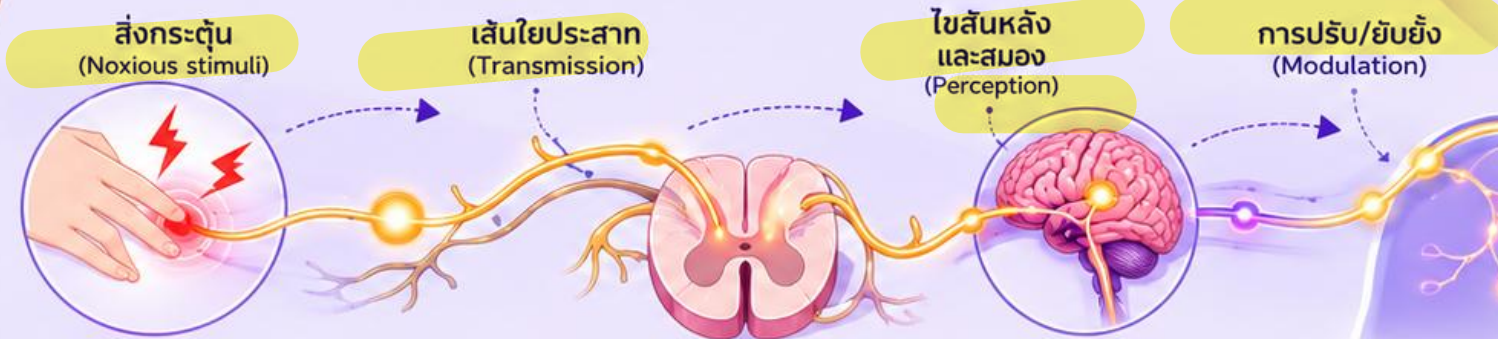
คำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความสุขสบาย

บรรเทาความปวด เติมเต็มความห่วงใย

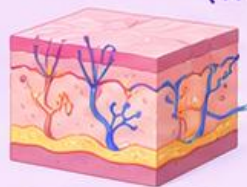
♥ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ♥

กระบวนการนำสัญญาณ ความเจ็บปวด

4 กระบวนการสำคัญของการรับรู้ความเจ็บปวด



1 การรับสิ่งเร้า (Transduction)



- ตัวรับรู้ความรู้สึกปวด (Pain receptors)
- เปลี่ยนสิ่งกระตุ้นเป็นสัญญาณไฟฟ้า



ความร้อน
ความเย็น



บาดเจ็บ



การอักเสบ
การติดเชื้อ



สารเคมี
อื่นๆ

2 การส่งผ่าน (Transmission)



- ส่งสัญญาณผ่านเส้นใยประสาท A fibers (เร็ว) และ C fibers (ช้า)
- ผ่านดอร์ซัลราก แกงเกลียน (Dorsal root ganglion)
- อาจเกิดปฏิกิริยาสะท้อน (Reflex)

3 การรับรู้ความเจ็บปวด (Perception)

- ประสาทที่ไขสันหลัง (SG)
- ส่งสัญญาณขึ้นสู่สมอง (Thalamus)
- แปลผลเป็นความรู้สึกและระดับความปวด



4 การปรับ (Modulation)

- สารปรับประสาท (Neuromodulators)
 - ยับยั้ง/ลดความเจ็บปวด
- ✓ เอ็นเคฟาลิน
 - ✓ เอ็นดอร์ฟิน
 - ✓ โดเนอร์ฟิน



“ การทำความเข้าใจกระบวนการนำสัญญาณความเจ็บปวด
ช่วยให้การประเมินและการพยาบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ”



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญจน์ณิชา เรืองชัยทวิสุข

ทฤษฎีการควบคุมประตู (Gate control theory)

กล่าวว่า กระแสความเจ็บปวดถูกควบคุม และปิดกั้นโดยกลไกการเปิด-ปิดประตูที่อยู่ในระบบประสาทส่วนกลาง (CNS)



ทฤษฎีนี้นำเสนอโดย

โรนัลด์ เมลแซค (Ronald Melzack)

นักจิตวิทยา และ

แพทริก วอลล์ (Patrick Wall)

นักสรีรวิทยา

ปี ค.ศ. 1965

หลักการง่ายๆ ของกลไกการเปิด-ปิดประตู



เปิดประตู → สัญญาณความเจ็บปวดถูกส่งต่อไปยังสมอง



ปิดประตู → สัญญาณความเจ็บปวดถูกปิดกั้น ไม่ถูกส่งต่อไปยังสมอง

บริเวณสำคัญในไขสันหลัง



SG cell

(Substantia gelatinosa cell)

ทำหน้าที่ควบคุมการเปิด-ปิดประตู



T cell

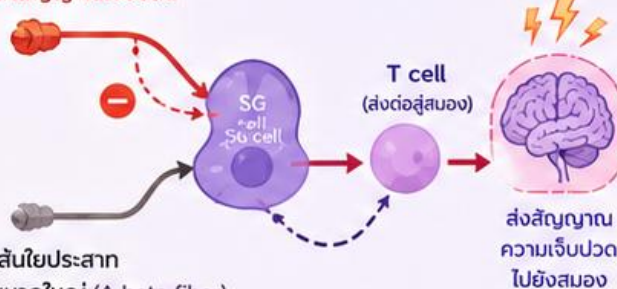
(Transmission cell)

เซลล์ประสาทส่งต่อ สัญญาณนำสัญญาณไปยังสมอง

กลไกการควบคุมประตูความเจ็บปวด

เปิดประตู (Pain signals pass)

เส้นใยประสาทขนาดเล็ก (C fiber) นำสัญญาณเจ็บปวด

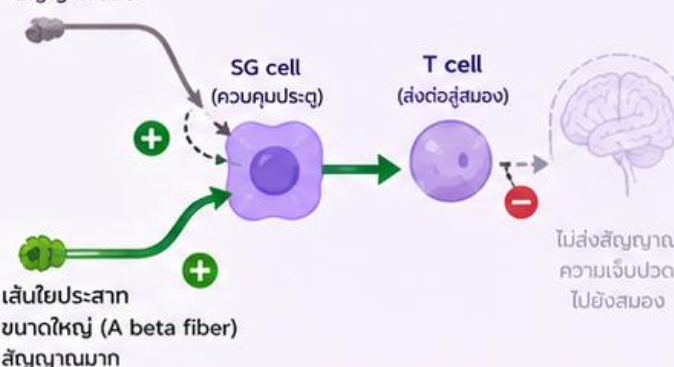


เส้นใยประสาทขนาดใหญ่ (A beta fiber) สัญญาณน้อย

สัญญาณจาก C fiber มาก
ยับยั้งการทำงานของ SG cell
ประตูเปิด สัญญาณผ่านไปยัง T cell และสมอง
เกิดความรู้สึกเจ็บปวด

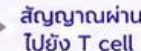
ปิดประตู (Pain signals blocked)

เส้นใยประสาทขนาดเล็ก (C fiber) สัญญาณน้อย



สัญญาณจาก A beta fiber มาก
กระตุ้นการทำงานของ SG cell
ประตูปิด สัญญาณถูกปิดกั้น ไม่ส่งต่อไปยังสมอง
ความเจ็บปวดลดลงหรือไม่เกิดขึ้น

สัญลักษณ์



เส้นใยประสาทขนาดเล็ก (C fiber) นำสัญญาณความเจ็บปวด



เส้นใยประสาทขนาดใหญ่ (A beta fiber) ช่วยปิดกั้นความเจ็บปวด

วิธีการปิดประตูเพื่อลดความเจ็บปวด



การนวด



การถู



การประคบ



การสั่นสะเทือนในระดับที่พอเหมาะ



ช่วยเพิ่มสัญญาณในเส้นใยประสาทขนาดใหญ่ ทำให้ประตูปิด ความเจ็บปวดลดลง



เข้าใจกลไกการควบคุมประตู ช่วยให้การประเมินและการจัดการความเจ็บปวดมีประสิทธิภาพมากขึ้น



ทฤษฎีการควบคุมความเจ็บปวดภายใน (Endogenous pain control theory)

ร่างกายสร้างสารคล้ายมอร์ฟีน (Endogenous opiates) เพื่อยับยั้งสัญญาณความเจ็บปวดตามธรรมชาติ

สารควบคุมความเจ็บปวดภายใน 3 ชนิด

1 เอ็นเคฟาลิน (Enkephalin)

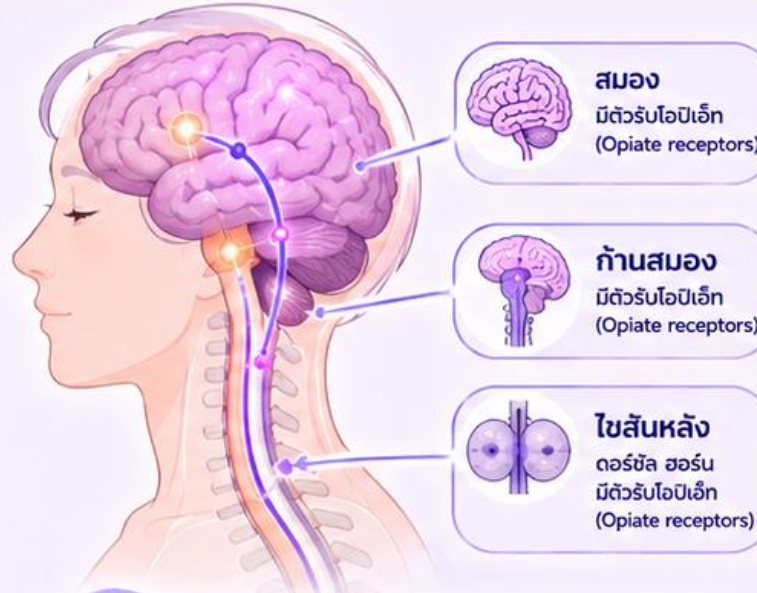
- 2 ชนิด: เมทไธโอนีน เอ็นเคฟาลิน (Methionine enkephalin) และ ลูซีน เอ็นเคฟาลิน (Leucine enkephalin)
- พบมากในสมอง ก้านสมอง และไขสันหลังบริเวณเอซจี (Substantia gelatinosa)
- ออกฤทธิ์ 1/4 - 1/2 เท่าของมอร์ฟีน
- ระยะเวลาในการระงับความเจ็บปวด: นานเป็นนาที

2 เอ็นดอร์ฟิน (Endorphins)

- ร่างกายสร้างสารโพลีเปปไทด์คล้ายมอร์ฟีน
- พบในสมอง ไฮโปทาลามัส และต่อมพิทูอิทารี
- มี 3 ชนิด: แอลฟา (Alpha) แกมมา (Gamma) เบตา (Beta)
- ออกฤทธิ์มากกว่ามอร์ฟีนประมาณ 10 เท่า
- อยู่ได้นาน 2-3 ชั่วโมง

3 ไดโนร์ฟิน (Dynorphin)

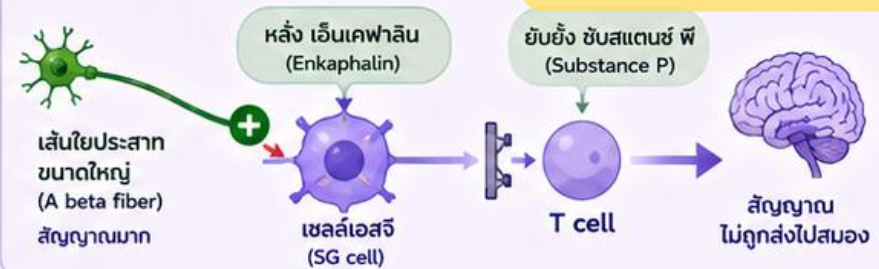
- พบมากในดอร์ซัล ฮอร์น (Dorsal horn) ของไขสันหลัง
- ฤทธิ์มากกว่ามอร์ฟีน 200 เท่า
- และมากกว่าเอ็นดอร์ฟิน 50 เท่า



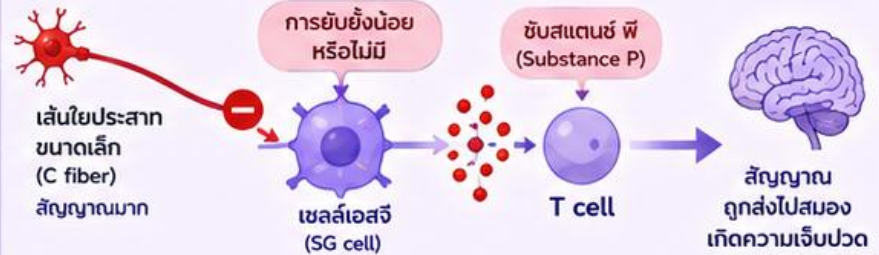
สารทั้ง 3 ชนิด จับกับตัวรับโอปิเอต ยับยั้งการหลั่งสารสื่อประสาทความเจ็บปวด ลดการส่งสัญญาณความเจ็บปวดไปยังสมอง

กลไกการควบคุมความเจ็บปวดภายใน

✓ ประตูปิด ความเจ็บปวดลดลง



✗ ประตูปิด ความเจ็บปวดเพิ่มขึ้น



เมื่อ A fiber ทำให้ SG cell ปิด SG cell ปิดจะทำให้ ทิ้ง เอ็นเคฟาลิน ซึ่งไปลดการปล่อย substance P ที่ T cell ทำให้ ลดความเจ็บปวดได้

วิธีเสริมการทำงานของระบบควบคุมความเจ็บปวดภายใน



การนวด



การลูบ



การประคบ



การสั่นสะเทือนที่เหมาะสม



การออกกำลังกายสม่ำเสมอ



การผ่อนคลายความเครียด



อารมณ์ดี หัวเราะ ฟังเพลง



พักผ่อนให้เพียงพอ



ร่างกายของเรามีระบบลดความเจ็บปวดในตัวเอง ดูแลร่างกายและจิตใจให้ดี จะช่วยให้ความเจ็บปวดลดลง

การประเมินความเจ็บปวด

การประเมินทางคลินิกพื้นฐาน เพื่อเข้าใจอาการปวดอย่างรอบด้าน และวางแผนการรักษาที่เหมาะสม

การประเมินทางคลินิกพื้นฐาน

- ✓ การซักประวัติ
- ✓ การตรวจร่างกาย
- ✓ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือการตรวจทางรังสี

1 การซักประวัติพื้นฐานเกี่ยวกับอาการปวด ข้อมูลสำคัญที่ควรประเมิน



เวลาที่เริ่มมีอาการปวด



รูปแบบของความปวด (เป็นๆ หายๆ หรือปวดตลอดเวลา)



ตำแหน่งที่ปวด และการกระจายของความปวด



ลักษณะความปวด (Pain characteristics) เช่น ปวดแสบร้อน ปวดตื้อ ปวดลึก



ระดับความรุนแรงของความปวด (NRS/VAS)



ปัจจัยที่ทำให้ความปวดเพิ่มขึ้นหรือลดลง



การตอบสนองต่อการเจ็บปวดหรือการรักษาในอดีต



อาการผิดปกติในระบบอื่น ๆ



ต้องประเมิน “สาเหตุของความปวดที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน (Emergency condition; Red flag)” เช่น มะเร็งปวดท้อง ประเมินภาวะฉุกเฉินในช่องท้อง (ลำไส้ทะลุ) เป็นต้น



เครื่องมือประเมินความปวดที่ใช้บ่อย



Numerical Rating Scale (NRS)



Visual Analog Scale (VAS)



Faces Pain Scale—Revised (FPS-R)



2 การซักประวัติเพื่อแยกประเภทความปวด

ประเมินลักษณะความปวด (Pain characteristics) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรักษา

1 Neuropathic pain

(ความปวดเหตุพยาธิสภาพประสาท)

เกิดจากโรคหรือความผิดปกติของระบบประสาทพบได้ทั้งใน



ระบบประสาทส่วนปลาย (Peripheral neuropathy)



ระบบประสาทส่วนกลาง (Central neuropathy)

ลักษณะความปวด
แสบร้อน ชา ไฟซัด แทงจืด
ไวต่อการสัมผัส (Allodynia)

2 Nociceptive pain

(ความปวดจากการกระตุ้นตัวรับความปวด)

เกิดจากโรคหรือความผิดปกติของอวัยวะที่ไม่ได้อยู่ในระบบประสาท

Somatic pain
(ปวดจากโครงสร้างร่างกายนอก)



กระดูก กล้ามเนื้อ ข้อต่อ
หรือเนื้อเยื่อภายนอก

ลักษณะความปวด
ปวดเฉพาะที่ ตำแหน่งชัดเจน
สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวหรือ
การกดเจ็บ

Visceral pain
(ปวดจากอวัยวะภายใน)



อวัยวะภายในช่องอก
หรือช่องท้อง

ลักษณะความปวด
ปวดลึก อึดอัด หน่วง ตื้อ
ตำแหน่งไม่ชัดเจน
อาจมีอาการร่วมอื่น ๆ

3 Nociplastic pain

(ความปวดจากการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการรับรู้ความปวด)

IASP ให้ความหมายว่า เป็นความปวดที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการรับรู้ความปวด (Altered nociception) โดยไม่พบหลักฐานชัดเจนของการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อหรือโรคและรอยโรคของระบบประสาทรับความรู้สึก



การวินิจฉัยทำได้ยาก
ต้องอาศัยการตรวจเพิ่มเติม เช่น
• Quantitative Sensory Testing (QST)
• MRI สมอง

ตัวอย่าง
Fibromyalgia

เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระบบรับรู้ความรู้สึกปวดส่วนกลาง
ทำให้ผู้ป่วยมีความไวต่อการรับความเจ็บปวดมากกว่าปกติ



การประเมินความปวดอย่างครอบคลุม ช่วยให้เข้าใจสาเหตุ วางแผนการรักษา และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย



ประเภทของการประเมินความปวด

แบ่งเป็น 2 ประเภท



1 การรายงานความปวดโดยผู้ป่วย (Self-report)

สามารถประเมินได้ทั้งการประเมินด้านเดียวและการประเมินหลายด้าน

1.1 การประเมินด้านเดียว (Unidimensional Pain Assessment)

เป็นการประเมินเฉพาะระดับความปวด (Pain intensity) นิยมใช้ในการประเมินความปวดเฉียบพลัน เช่น อาการปวดหลังผ่าตัดหรือความปวดภายหลังได้รับหัตถการ

รูปแบบการประเมิน

2
1 2 3

Numerical Rating Scale (NRS)
0 = ไม่ปวด 10 = ปวดมากที่สุด



Verbal Rating Scale (VRS)
บอกระดับความปวดด้วยคำพูด



Facial Pain Scale (FPS)
ประเมินระดับความปวดจากสีหน้า

1.2 การประเมินหลายด้าน (Multidimensional Pain Assessment)

เป็นการประเมินผลกระทบของความปวดในหลายมิติ ทั้งระดับความปวดและผลกระทบที่เกิดจากความปวด



ด้านร่างกาย

- การทำกิจวัตร
- การนอนหลับ



ด้านจิตใจ

- ภาวะอารมณ์
- ความเครียด



ด้านสังคม

- การเข้าสังคม
- บทบาทหน้าที่

วิธีการประเมิน



แบบประเมินที่ผู้ป่วยกรอกด้วยตนเอง

หรือ



การสัมภาษณ์

การประเมินขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแบบประเมินแต่ละประเภท

ตัวอย่างการประเมินระดับความปวดด้วยตนเอง

Numerical Rating Scale (NRS)



Verbal Rating Scale (VRS)



Visual Analog Scale (VAS)



Faces Pain Scale-Revised (FPS-R)



2 การประเมินความปวดด้วยการสังเกตพฤติกรรม (Behavioral Pain Assessment)

ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาในการสื่อสาร เช่น เด็กอายุ 1-6 ปี ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านการสื่อสาร



เด็กอายุ 1-6 ปี



ผู้สูงอายุที่มีปัญหา
ด้านการสื่อสาร



ผู้ป่วยที่ไม่สามารถ
สื่อสารได้อย่างชัดเจน

ควรเลือกแบบประเมินให้เหมาะสมกับ



ประเภทของความปวด

- ความปวดเฉียบพลัน
- ความปวดเรื้อรัง
- ความปวดระยะสุดท้ายของชีวิต



บริบทของผู้ป่วย

- หอผู้ป่วยวิกฤต (ICU)
- ห้องฉุกเฉิน (ER)
- หอผู้ป่วยทั่วไป



ลักษณะพฤติกรรม

- สีหน้า
- การเคลื่อนไหว
- เสียงร้อง / ทำท่าทาง
- การตอบสนองต่อการสัมผัส



สภาพแวดล้อม
ในการดูแล



การประเมินความปวดอย่างถูกต้องและเหมาะสม จะช่วยในการวางแผนการรักษาและติดตามผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ



วิธีการบำบัดความปวด

แบ่งเป็น 2 วิธี

1 การบำบัดความปวดด้วยยา (Pharmacological approach)

การให้ยาระงับปวดในกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่ opioids, weak opioids (codeine, tramadol), NSAIDs, COX-2 inhibitor และ paracetamol

การใช้ยาแก้ปวดแบ่งตามกลไกการออกฤทธิ์

1 Acetaminophen (Paracetamol)

กลไกการออกฤทธิ์ไม่แน่ชัด คาดว่าอาจออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ Cyclooxygenase-2 (COX-2) หรือเพิ่มการหลั่ง endogenous cannabinoid ซึ่งมีฤทธิ์ระงับปวด หรือยับยั้งการทำงานของตัวรับ NMDA (N-Methyl D-Aspartate receptor) ทำให้ลดการส่งสัญญาณปวดขึ้นสู่สมอง



ขนาดที่ใช้: 10-20 มก./กก. ทุก 4-6 ชม.
ขนาดสูงสุดในผู้ใหญ่: 4,000 มก.ต่อวัน

2 NSAIDs และ COX-2 inhibitor

ยาทั้งสองกลุ่มยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ COX-2 ทำให้ลดการเปลี่ยน arachidonic acid เป็น prostaglandin ชนิด E-2 (PG-E2) ทำให้ลดการอักเสบและอาการปวด



ควรหลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ป่วยที่มี
ภาวะไตบกพร่องระดับปานกลางถึงรุนแรง
(GFR = 15-59 mL/min/1.73m²)

ขนาดยาที่แนะนำ (ผู้ใหญ่)

ยา	ขนาดยา	ความถี่ (ทุก)
 Ibuprofen	400-800 mg	6-8 ชม.
 Diclofenac	50 mg	8 ชม.
 Naproxen	250-500 mg	12 ชม.
 Ketorolac	10-30 mg (IV/IM)	6-8 ชม.
 Celecoxib	200 mg	12 ชม.
 Etoricoxib	60-120 mg	24 ชม.
 Parecoxib (IV)	40 mg	12 ชม.

2 การบำบัดความปวดโดยไม่ใช้ยา (Non-pharmacological approach)



การผ่อนคลาย
การหายใจลึก
สมาธิ



การสัมผัส
การนวด
ประคบเย็น/อุ่น



ดนตรีบำบัด
ช่วยลดความเครียด
และความปวด



การเคลื่อนไหว
และการออกกำลังกาย
ที่เหมาะสม



การให้ความรู้
และการเสริมพลัง
แก่ผู้ป่วย

ข้อควรระวัง / ข้อห้ามในการใช้ NSAIDs และ COX-2 inhibitor



ภาวะไตบกพร่องระดับปานกลางถึงรุนแรง
(GFR = 15-59 mL/min/1.73m²)



การทำงานของเกล็ดเลือดผิดปกติ
หรือจำนวนเกล็ดเลือดต่ำ



มีเลือดออกในทางเดินอาหาร
(active gastrointestinal bleeding)



ภาวะหลอดลมตีบรุนแรง
(active bronchospasm)



มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือ
หลอดเลือดในสมองตีบที่อาการ
ของโรคยังควบคุมได้ไม่ดี
(active coronary/cerebral
vascular diseases)



ภาวะตั้งครรภ์ในไตรมาสแรก
และไตรมาสที่สาม
(first and third trimester
of pregnancy)



ไม่ให้ parecoxib ในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด CABG
(coronary artery bypass graft) เนื่องจากจะเพิ่ม
อัตราการเกิดหัวใจขาดเลือดหรือหัวใจวายได้



ผู้ที่แพ้ยา sulfonamide ห้ามให้ parecoxib และ celecoxib เพราะสูตรโครงสร้างมี sulfa



วิธีการบำบัดความปวดด้วยยา (ต่อ)

กลไกการออกฤทธิ์ของยาระงับปวดแต่ละกลุ่ม

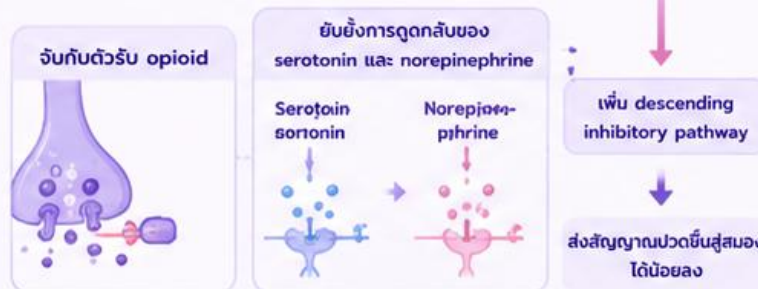
3 Strong opioids (morphine, pethidine, fentanyl)

จับกับตัวรับ opioid ที่บริเวณ dorsal horn ของไขสันหลังและสมอง ทำให้เซลล์ที่รับสัญญาณปวด ทำงานน้อยลง



4 Weak opioids (tramadol, codeine)

- จับกับตัวรับ opioid ได้น้อยกว่า strong opioid เป็นร้อยเท่า
- Codeine จะต้องถูกเปลี่ยนเป็นมอร์ฟีน ที่ตับจึงจะออกฤทธิ์ระงับปวดได้
- Tramadol ออกฤทธิ์สองกลไก



5 Alpha-2 agonist (dexmedetomidine)

กระตุ้นตัวรับ alpha-2 ทำให้เกิดผลดังนี้



มีฤทธิ์ระงับปวดสั้น ต้องหยุดต่อเนื่อง บิยามใช้เฉพาะในการบำบัดปวดหลังผ่าตัด

6 ยาเสริม (adjuvant)

ใช้เพื่อลดปริมาณยาระงับปวด หรืออาจใช้เมื่อมีความปวดจากเส้นประสาท (neuropathic pain) ซึ่งตอบสนองต่อยา opioids ไม่ได้

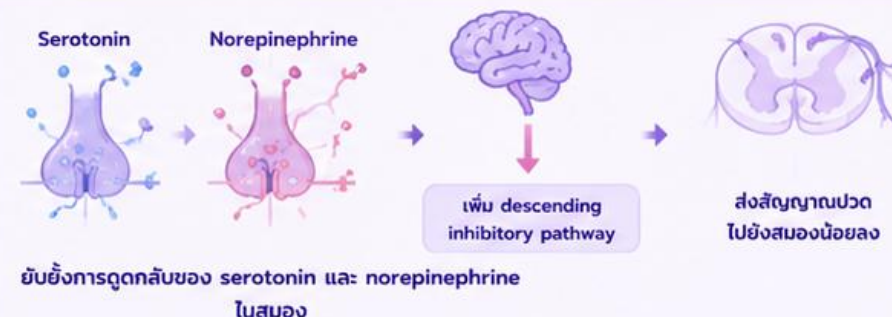


1 ยายับยั้งการทำงานของช่องแคลเซียม (Calcium channel blocker) ได้แก่ gabapentin, pregabalin



ใช้ลดอาการปวดหลังผ่าตัด โดยต้องใช้ร่วมกับ strong opioids ช่วยลดปริมาณ strong opioids ได้ และยังช่วยลด neuropathic pain

2 ยาต้านซึมเศร้า กลุ่ม SNRI (serotonin norepinephrine reuptake inhibitor)



หลักการเลือกใช้ยาระงับปวด

ตามแนวทาง “บันไดสามขั้นขององค์การอนามัยโลก” (WHO analgesic ladder)



ประเมินระดับความปวด



หลักการสำคัญ

- ✓ เริ่มจากขั้นที่ 1
- ✓ ถ้ายังปวด ให้เพิ่มระดับขึ้นตามขั้นบันได
- ✓ ให้ยาเป็นเวลาอย่างสม่ำเสมอ
- ✓ ให้ยาตามขนาดที่เหมาะสมกับผู้ป่วย
- ✓ พิจารณาอาการไม่พึงประสงค์และข้อห้ามในการใช้ยา

1

บันไดขั้นที่ 1 ความปวดระดับน้อย NRS < 4

ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดขนาดเล็ก
เช่น การถอนฟัน หรือมีอาการปวด
ระดับน้อย

ยาแนะนำ

Non-opioid

- NSAIDs หรือ COX-2 inhibitor
- Acetaminophen



2

บันไดขั้นที่ 2 ความปวดระดับปานกลาง NRS = 4-6

ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดขนาดกลาง
เช่น ผ่าตัดถอนฟันที่เต้านม หรือยังปวดอยู่
หลังได้รับยาในบันไดขั้นที่ 1

ยาแนะนำ

Weak opioids

- Tramadol
- Codeine



3

บันไดขั้นที่ 3 ความปวดระดับรุนแรง NRS = 7-10

ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่
เช่น ผ่าตัดทรวงอก ผ่าตัดท้องส่วนบน
หรือยังปวดอยู่หลังได้รับยา
ในบันไดขั้นที่ 2

ยาแนะนำ

Strong opioids

- Morphine
- Pethidine
- Fentanyl



ประเมินความปวดอย่างสม่ำเสมอ ปรับขนาดยาให้เหมาะสม และเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ของยาอย่างใกล้ชิด

ขอบคุณ ที่ตั้งใจฟัง

การบรรเทาความปวด คือ การดูแลด้วยใจ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วย

